

UNIDAD DE CORTA ESTANCIA

Alberto Morán Blanco

INTRODUCCIÓN

Las Unidades de Corta Estancia (UCE) constituyen una alternativa a la hospitalización convencional, su función es la hospitalización para observación y/o tratamiento de pacientes durante un tiempo inferior a 3 días con la finalidad de reducir estancias hospitalarias y costes, disminuyendo la saturación de pacientes en los servicios de Urgencias y la falta de camas disponibles, manteniendo igual perfil de seguridad y satisfacción del paciente que la hospitalización convencional.

El buen funcionamiento de las UCE se basa en la adecuada selección de pacientes, en general puede ingresar cualquier enfermo en el que sea previsible el alta en 72 horas. Habitualmente descompensaciones de procesos crónicos, evitando pacientes sin diagnóstico claro y/o que precisen de la realización de pruebas diagnósticas.

Tributarios de ingresar en la UCE son los siguientes procesos:

- Insuficiencia cardíaca y EPOC descompensadas. Bronquitis aguda con insuficiencia respiratoria leve.
- Fiebre de pocas horas de duración con una orientación diagnóstica razonable (infección urinaria, pielonefritis, neumonías, colecistitis aguda, diverticulitis, celulitis) para ver evolución y/o respuesta a tratamiento antibiótico tras toma de cultivos y no sean formas complicadas, no debe cumplir criterios qSOFA.
- Hidratación en diarreas agudas o vómitos.
- Alteraciones iónicas (causa evidente).
- Golpe de calor. Rabdomiolisis.
- Hiper o hipoglucemias.
- Control de arritmias (flutter o fibrilación auricular).
- Crisis hipertensiva.
- Intoxicaciones involuntarias leves.
- Sobredosificación de anticoagulación.
- Realización de paracentesis, toracocentesis o punciones lumbares evitando el ingreso.

Tan importante como lo que puede es lo que no debería ingresar en la UCE y serían:

- Cuadros graves: sepsis, inestabilidad hemodinámica.
- Ingresos para estudio: anemia no filiada, cuadro constitucional, sospecha de proceso neoplásico... En estos casos valorar remitir a Unidad de Diagnóstico Rápido o Consulta de Alta Resolución si hay disponibilidad.

Son conocidas como causas que dificultan el alta precoz los problemas sociales (vive solo, ausencia de ayuda en el entorno...), el deterioro funcional importante (dificultades de movilidad, falta de autonomía, Barthel inferior a 60...) y/o la presencia de comorbilidad elevada (Charlson o PROFUND).

Es importante explicar al paciente y/o a su familia la finalidad de la UCE, que no es otra que el alta precoz ante la mejoría del problema médico que lo llevó al Hospital. Y que será derivado a su domicilio para seguimiento por parte de su médico de cabecera y si fuera necesario a las

consultas externas del hospital.

Procedimiento de alta de la UCE:

- A domicilio tras mejoría. Se hará el Informe de Alta con la información clínica del proceso y el tratamiento prescrito, así como las recomendaciones de seguimiento por su médico de cabecera y será remitido a Consulta Externa del Hospital para seguimiento si fuera necesario. Se facilitarán las recetas que precise.
- Ingreso en planta de hospitalización convencional, tras ausencia de mejoría.

La dependencia de la UCE en el organigrama del Hospital es variable de unos centros a otros y va desde la propia Dirección Médica del Hospital a serlo de los Servicios de Urgencias o de Medicina Interna. E incluso la atención médica puede depender de un único Servicio o ser compartida por varios, en estos últimos suele existir una figura aglutinadora que dependerá del Servicio a la que pertenezca la Unidad. Esta dependencia organizativa influye directamente en el tipo de procesos que pueden ser ingresados en la misma por ejemplo, ausencia de patología quirúrgica si lo es de Medicina Interna.

Finalmente, diferenciar la UCE del Área de Observación de Urgencias, la finalidad de una y otra es bien distinta y coexisten sin problemas.

- ¡ IMPORTANTE !
- Tener claro que patologías son subsidiarias de ingresar en la UCE y cuáles no. Tan importante es lo uno como lo otro. De ello va a depender el buen funcionamiento de la unidad.

BIBLIOGRAFÍA

- Marcos M, Hernández-García I, Ceballos-Alonso C, et al. Influencia de las unidades de corta estancia en la calidad de la atención hospitalaria en España. Revisión sistemática. Rev Calid Asist. 2013; 28: 199-206.
- González-Armegol JJ, Fernández C, Martín FJ, et al. Actividad de una unidad de corta estancia de urgencias de un hospital terciario: cuatro años de experiencia. Emergencias. 2009; 21: 87-94.
- Juan A , Enjamio E, Moya C, et al. Impacto de la implementación de medidas de gestión hospitalaria para aumentar la eficiencia en la gestión de camas y disminuir la saturación del servicio de urgencias. Emergencias. 2010; 22: 249- 253.
- R. Guirao Martínez, M.T. Sempere Selva, I. et al. Unidad de corta estancia, una alternativa a la hospitalización convencional. Rev Clin Esp, 2008; 208: 216-221.